BICENTENARIO DE BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CURSO 3:

PREVENCIÓN DE ITS Y VIH/SIDA

UNEFCO
Unidad Especializada de Formación Continua

CONTENIDO

CONTENIDO ____ I
PRESENTACIÓN ____ III
DATOS GENERALES DEL CUADERNO ____ V
OBJETIVO HOLÍSTICO DEL CICLO ____ V
OBJETIVO DEL CURSO ____ V
PERFIL DE SALIDA ____ V
Tema 1: ITS/VIH ____ 1
ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO ____ 3
1.1. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) ____ 3
1.2. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LAS ITS ____ 4
1.3. INFECCIONES QUE PUEDEN O NO MANIFESTAR SÍNTOMAS EVIDENTES ____ 5
1.4. FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LAS ITS ____ 5
1.5. FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DE LAS ITS ____ 6
1.5.1. Factores biológicos ____ 7
1.5.2. Factores conductuales ____ 7
1.5.3. Factores sociales ____ 8
1.6. LAS COMPLICACIONES DE LAS ITS ____ 8
1.7. CÓMO ACTÚAN LOS TRATAMIENTOS Y SU IMPORTANCIA ____ 10
1.8. INFECCIONES QUE NO SON CURABLES CON TRATAMIENTO ____ 11
1.9. LAS ITS Y EL VIH COMO CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ____ 11
1.10. EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) ____ 12
a) Diagnóstico y prevención del cáncer de cuello uterino producido por el VPH ____ 13
ACTIVIDAD PARA EL AULA (Secundaria) ____ 15
ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO ____ 18
Tema 2: VIH/SIDA ____ 19
ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO ____ 21
2.1. LA EPIDEMIA DE VIH/SIDA ____ 21
2.2. ¿QUÉ ES EL VIH? ____ 22
2.3. LA RELACIÓN ENTRE LAS ITS Y EL VIH/SIDA ____ 23
2.4. FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH ____ 24
2.4.1. ¿Cómo ocurre la transmisión del VIH por vía sanguínea? ____ 25
2.4.2. ¿Cómo ocurre la transmisión por vía sexual? ____ 25
2.4.3. ¿Cómo ocurre la transmisión por vía materno perinatal? ____ 26
2.5. MANERAS EN QUE NO SE TRANSMITE EL VIH ____ 27

2.6. PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DEL VIH ____ *28*
2.7. VIVIR POSITIVAMENTE CON EL VIH ____ *31*
2.8. EL VIH Y LOS DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS ____ *32*
ACTIVIDAD PARA EL AULA (Secundaria) ____ *33*
ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO ____ *35*
Tema 3: PREVENCIÓN DE LAS ITS/VIH/SIDA ____ **37**
ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO ____ *39*
3.1. EL DESAFÍO DE CONTROLAR LAS ITS/VIH/SIDA (OMS, 2009) ____ *39*
a) Factores relacionados con el sistema de salud ____ *39*
b) Factores biológicos ____ *39*
c) Factores sociales y conductuales ____ *40*
d) Factores relacionados con el ámbito educativo ____ *41*
3.2. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ITS/VIH/SIDA ____ *42*
3.2.1. Prevención primaria ____ *42*
3.2.2. Prevención secundaria ____ *42*
3.2.3. Atención integral en los centros de salud ____ *43*
3.3. LAS RELACIONES SEXUALES SEGURAS ____ *43*
3.4. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ITS/VIH/SIDA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ____ *44*
3.4.1. Niñez ____ *44*
3.4.2. Adolescencia ____ *45*
ACTIVIDAD PARA EL AULA (Secundaria) ____ *49*
ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO ____ *51*
BIBLIOGRAFÍA ____ **53**
GLOSARIO ____ **55**

Presentación

En este año histórico, en el que Bolivia conmemora 200 años de independencia, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO), asume con firmeza el desafío de transformar la educación en nuestro país.

La UNEFCO, con una trayectoria sólida y reconocida, ha diseñado una estrategia de formación continua innovadora y transformadora, alineada con los principios constitucionales y las demandas actuales del Sistema Educativo Plurinacional (SEP). Nuestro objetivo es claro, empoderar a las maestras/os y actores del SEP como agentes de cambio, capaces de liderar una educación que responda a los desafíos y necesidades de nuestra diversidad cultural.

En este contexto, presentamos las Acciones Formativas, como una propuesta flexible, práctica y profundamente conectada con la realidad de las aulas. El desarrollo de los cursos/ciclos no solo respeta los ritmos y tiempos de cada docente, sino que también les invita a ser protagonistas de su propio crecimiento profesional, con herramientas que les permitan transformar su práctica educativa y, con ella, la vida de miles de estudiantes.

En el marco del Bicentenario, nuestra formación continua se enfoca en dos ejes estratégicos, inspirados en la Agenda Patriótica 2025 y en las prioridades del Ministerio de Educación:

1. Fortalecer las condiciones para una educación de calidad, promoviendo prácticas innovadoras, inclusivas y pertinentes a nuestra realidad plurinacional.

2. Posicionar a la educación como el corazón de la transformación social, reconociendo su poder para construir una Bolivia más justa, equitativa y soberana.

Los cuadernos de formación continua, elaborados por la UNEFCO, más que materiales educativos; son una invitación a la reflexión, innovación y acción. Cada unidad temática está diseñada para inspirar, motivar y proporcionar herramientas concretas que permitan a las y los maestros llevar a sus aulas una educación que trascienda lo convencional y se convierta en un espacio de transformación real.

En este Bicentenario, no solo celebramos nuestro pasado, sino que también miramos hacia el futuro con determinación. La educación es, y será siempre, la herramienta más poderosa para construir la Bolivia que soñamos. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos de maestras y maestros comprometidos e innovadores, capaces de liderar este cambio.

Invitamos a todas y todos los actores del SEP a sumarse a este proceso de formación continua y juntos, construyamos una educación que honre nuestro pasado, transforme nuestro presente y garantice un futuro lleno de oportunidades para las próximas generaciones.

Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO)

Bicentenario de Bolivia: 200 años de lucha, unidad y esperanza

RUTA DE APRENDIZAJE DE LOS CICLOS FORMATIVOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN DESPATRIARCALIZADORA - ITINERARIOS FORMATIVOS PARA MAESTRAS, MAESTROS Y OTROS ACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL.



DATOS GENERALES DEL CUADERNO



OBJETIVO HOLÍSTICO DEL CICLO:

Afianzar el reconocimiento de la sexualidad como dimensión humana y derecho fundamental, para la formación integral de la comunidad educativa, a través del análisis y reflexión de problemáticas de la comunidad para la construcción de temas y conceptos claves contribuyendo a la implementación de la Educación Integral en Sexualidad desde los Ejes Articuladores y los Campos de Saberes y Conocimientos fortaleciendo principios y valores respetuosos de los Derechos Humanos.

OBJETIVO DEL CURSO:

Fortalecer conocimientos y capacidades sobre prácticas saludables que contribuyen a la prevención integral de ITS y VIH/SIDA en adolescentes y jóvenes, implementando herramientas pedagógicas en el marco de los derechos sexuales, generando actitudes de responsabilidad y compromiso con la salud comunitaria.

PERFIL DE SALIDA:

Las y los participantes han desarrollado competencias para promover en el sector educativo estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria de las ITS y del VIH/SIDA, con énfasis en la población de las y los adolescentes.

BICENTENARIO DE BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Tema 1

ITS/VIH

UNEFCO
Unidad Especializada de Formación Continua

ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO

Reflexionar sobre los conocimientos, creencias e inquietudes que se tiene sobre las ITS/VIH/SIDA y sus efectos en la vida de las mujeres y de los hombres.

1.1. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

No toda infección en los órganos sexuales se debe considerar como una Infección de Transmisión Sexual. Por ejemplo, puede ser que una adolescente presente secreción o flujo vaginal por alteraciones del PH (grado relativo de acidez) en su vagina, como suele ocurrir por el uso de lavados vaginales frecuentes, pantaletas muy ajustadas, ropa interior de color oscuro en época de calor, pastillas anticonceptivas o cuando se tiene alguna enfermedad inmunológica o endócrina como la diabetes.

En estas circunstancias es probable que la adolescente desarrolle una infección clasificada dentro del tipo de "secreción". En este caso sugerimos no utilizar el término de ITS, sino el de infección genital, pues la infección se ha presentado sin que exista una relación sexual que la haya originado y se pueden presentar sin que se haya tenido una relación sexual. Por ejemplo: La vaginosis bacteriana es una enfermedad frecuente que aparece cuando se altera el equilibrio normal de los microorganismos de la vagina, sin importar su actividad sexual. Se produce cuando microorganismos que no forman parte de la flora vaginal habitual desequilibran las bacterias "buenas" y las

"dañinas". Los síntomas incluyen ardor, comezón, inflamación, dolor, flujo abundante o mal olor.

Sin embargo, una infección genital se convierte en ITS en el momento en que la persona que la tiene se la transmite a su pareja a través de las relaciones sexuales no protegidas. Por consiguiente, las ITS son aquellas infecciones adquiridas por la transmisión de un microorganismo (bacteria, virus, hongo, parásito, entre otros.) durante las relaciones sexuales, sobre todo cuando existe intercambio de fluidos corporales durante una relación sexual desprotegida.

1.2. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LAS ITS

Existen muchos tipos de infecciones de transmisión sexual y son muy comunes; más de la mitad de las personas tendrá una infección de transmisión sexual en algún momento de su vida.

Numerosos organismos causantes de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) sólo dan origen a un número limitado de síndromes. Un síndrome es simplemente un grupo de síntomas sobre los que consulta un o una paciente y los signos clínicos son los que el médico o médica observa durante el examen físico. Esta tabla explica los signos y síntomas de los principales síndromes de ITS y sus causas. El objetivo del manejo sindrómico es identificar uno de estos siete síndromes y manejarlo según corresponde.

MANEJO SINDRÓMICO DE LAS ITS (OMS, 2008)		
SINTOMAS	**SIGNOS**	**ETILOGIA MAS COMUN EN BOLIVIA**
Picazón vulva, vagina o ano	Flujo vaginal anormal (blanquecino, amarillos, purulento con o sin sangre)	• Tricomoniasis • Candidiasis • Gonorrea • Clamidia
Dolor al orinar		
Dolor durante el acto sexual		
Necesidad de orinar frecuentemente	Flujo por la uretra	
Dolor abdominal o bajo vientre	Temperatura más de 38º C	
Dolor en la ingle	Hinchazón de ganglios linfáticos de la ingle	• Sífilis • Chancroide • Herpes Genital
Dolor en el escroto	Hinchazón del escroto	
Ardor al orinar	Ulceras en boca, vulva, vagina o ano (dependiendo el tipo de relación sexual que se practicó)	
Dolor durante el acto sexual	Vesículas boca, vulva, vagina o ano (dependiendo el tipo de relación sexual que se práctico)	
	Verrugas boca vulva, vagina o ano (dependiendo el tipo de relación sexual que se práctico)	

¿Qué hacer si se sospecha de una ITS?

1. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano.
2. No automedicarse.
3. Tomar en cuenta que los exámenes en los centros de salud son confidenciales. El personal de salud está capacitado para atender las ITS, por lo que es necesario sentir pudor o vergüenza.
4. En los servicios de salud para adolescentes públicos es posible recibir la atención de manera gratuita con el Seguro Único de Salud. Por ello es muy importante acudir a un centro de salud cercano al propio domicilio.
5. Se debe informar a las personas con las que se tuvo relaciones coitales para que también reciban atención médica.

1.3. INFECCIONES QUE PUEDEN O NO MANIFESTAR SÍNTOMAS EVIDENTES

En general cualquier ITS puede presentar periodos en los que no se manifiesta ningún síntoma y/o signo evidente, son asintomáticos; es una de las razones por las cuales se cambió el término de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) por Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) porque algunas personas pueden tener una infección en el cuerpo durante algún tiempo e incluso años sin manifestar la enfermedad, como es el caso del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que puede tardar hasta 10 años o más en expresarse mediante síntomas y signos. De manera similar ocurre con la hepatitis B y C, pues en la mayoría de las personas la ITS se manifiesta de 15 a 20 años después de que se contrajo la infección y muy frecuentemente esto ocurre en la etapa de la adolescencia (Casanova, 2004, p. 41).

1.4. FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LAS ITS



Es importante recordar que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se transmite de la misma manera que cualquier otra ITS.

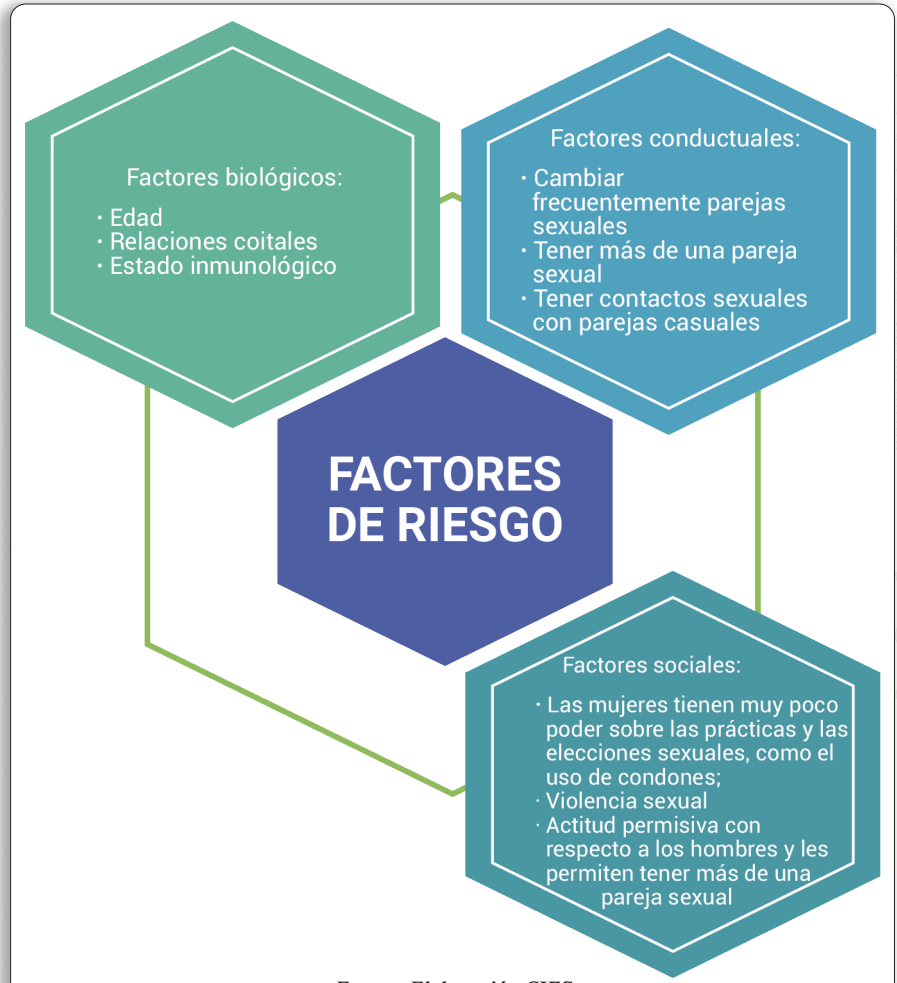
La forma más común de transmisión de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) es a través del contacto sexual sin protección y con penetración (vaginal o anal).

Otras formas, menos frecuentes, de transmisión incluyen:

- La transmisión vertical (madre a hijo).
- Durante el embarazo (por ej., VIH y sífilis).

- En el momento del parto (por ej., gonorrea, clamidia y VIH).
- Después del parto (por ej., VIH) - a través de la leche materna (por ej., VIH).
- El uso arriesgado de agujas o inyecciones (sin esterilizar) u otro contacto con sangre o hemoderivados (por ej., sífilis, VIH y hepatitis).

1.5. FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DE LAS ITS



Fuente: Elaboración CIES

No todos los casos de contacto sexual sin protección se traducen en la transmisión de una ITS de una persona infectada a su pareja. Si una persona se infecta o no dependerá de muchos factores, tanto biológicos como conductuales y sociales.

1.5.1. Factores biológicos

Algunos factores biológicos tienen influencia sobre la transmisión de las ITS. Éstos son la edad, el sexo, el estado inmunológico del huésped y la virulencia del agente infeccioso.

Edad

La mucosa vaginal y el tejido cervical en las mujeres jóvenes son inmaduros y las hace más vulnerables a las ITS que las mujeres mayores. Esto se debe a la ectopia cervical, un trastorno normal en mujeres jóvenes que ocurre cuando las células que se encuentran en la superficie cervical permiten que las infecciones ocurran con mayor facilidad. Las mujeres jóvenes se encuentran especialmente en riesgo en aquellas culturas en las que el matrimonio o la iniciación sexual ocurren durante la adolescencia temprana. En promedio, las mujeres se infectan a una edad más temprana que los hombres.

Relaciones coitales

Las infecciones ingresan al organismo con mayor facilidad a través de las membranas mucosas como el revestimiento de la vagina. Como la superficie mucosa que entra en contacto con el agente infeccioso es mucho mayor en mujeres que en hombres, las mujeres pueden infectarse más fácilmente que los hombres.

Estado inmunológico

El estado inmunológico del huésped y la virulencia del agente infeccioso afectan la transmisión de las ITS. Algunas ITS aumentan el riesgo de transmisión de VIH, que también es una infección de transmisión sexual. El VIH, a su vez, facilita la transmisión de algunas ITS y agrava las complicaciones, ya que debilita el sistema inmunológico.

1.5.2. Factores conductuales

Muchos factores conductuales podrían afectar las probabilidades de contraer una ITS. Tales conductas se conocen como arriesgadas. Las conductas arriesgadas incluyen:

- Conductas sexuales personales.
- Cambiar frecuentemente de parejas sexuales.
- Tener más de una pareja sexual.
- Tener contactos sexuales con parejas “casuales”: tener contactos sexuales con penetración sin protección en una situación en la que cualquiera de los participantes tiene una infección.

- Haber tenido una ITS durante el último año: las personas que han tenido una ITS durante el último año corren el riesgo de volver a contraer la infección si no han logrado cambiar su conducta sexual.

1.5.3. Factores sociales

Numerosos factores sociales relacionan el sexo con las cuestiones conductuales y podrían afectar el riesgo que corre una persona de contraer una ITS:

- En la mayoría de las culturas las mujeres tienen muy poco poder sobre las prácticas y las elecciones sexuales, como el uso de condones.
- Las mujeres tienden a depender económicamente de sus parejas y, por lo tanto, son más propensas a tolerar conductas arriesgadas por parte de los hombres, como tener parejas sexuales múltiples, que las ponen en peligro de contraer infecciones.
- La violencia sexual tiende a estar dirigida más hacia las mujeres por parte de los hombres, lo que hace que sea más difícil para las mujeres hablar sobre las ITS con sus parejas.
- En algunas sociedades es común casar a las niñas a una edad muy temprana con un hombre adulto; esto expone a la niña a infecciones.
- En algunas sociedades toman una actitud permisiva con respecto a los hombres y les permiten tener más de una pareja sexual.

Otras conductas personales pueden estar asociadas con el riesgo:

- La perforación de la piel; esto se refiere a una amplia gama de prácticas que incluyen el uso de agujas sin esterilizar para colocar inyecciones o realizar tatuajes, la escarificación o el "piercing" corporal y la circuncisión mediante el uso compartido de elementos cortantes.
- El uso de alcohol u otras drogas antes o durante el contacto sexual; el uso de alcohol o drogas podría afectar negativamente el uso del condón; el alcohol podría disminuir la percepción del riesgo, que se traduce en no usar condón o, en el caso de que se use, podría no utilizarse en forma correcta.

La conducta arriesgada de la(s) pareja(s) incluye:

- Tener contactos sexuales con otras personas.
- Tener una ITS; inyectarse drogas.

Una pareja que exhibe uno o más de estas conductas está más expuesta a las ITS y, a su vez, es más propensa a transmitir una ITS.

1.6. LAS COMPLICACIONES DE LAS ITS

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) representan una cuestión prioritaria en la salud pública no solo por su elevada prevalencia a nivel

mundial, sino también por su potencial para causar complicaciones graves y permanentes en las personas infectadas que no reciben un tratamiento oportuno y efectivo. Además, estas infecciones facilitan la transmisión del VIH.

- Tanto las infecciones sintomáticas como las asintomáticas pueden provocar el desarrollo de complicaciones graves.
- Las complicaciones y secuelas (consecuencias a largo plazo) más graves que pueden tener las ITS que no reciben tratamiento se dan generalmente en mujeres y recién nacidos. Éstas incluyen el cáncer cervical, la enfermedad pélvica inflamatoria (salpingitis), el dolor pélvico crónico, la muerte fetal, el embarazo ectópico y la mortalidad materna relacionada.
- Las infecciones por clamidia y gonorrea son causas importantes de infertilidad, especialmente en mujeres, con consecuencias sociales de gran repercusión. La infección por clamidia es una causa importante de neumonía en los neonatos. La infección gonocócica neonatal de los ojos puede provocar ceguera.
- La sífilis congénita es una causa importante y significativa de morbimortalidad infantil. En los adultos, la sífilis puede provocar graves consecuencias cardíacas y neurológicas entre otras, que pueden finalmente ser mortales.

En la tabla que se presenta a continuación se resumen las complicaciones:

Posibles complicaciones de las ITS	
Infección por gonococo y clamidia	Infertilidad en hombres y mujeres Epididimitis Embarazo ectópico a causa del daño tubárico
Gonorrea	Ceguera en neonatos
Infección por gonococo, clamidia y bacterias anaeróbicas	Peritonitis pélvica y generalizada
Sífilis adquirida	Daño cerebral y cardiopatía permanentes
Papilomavirus humano (VPH)	Cáncer genital

Otros datos interesantes sobre las aplicaciones de las ITS

La enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), provocada por la gonorrea y la clamidia, es una inflamación del tejido uterino (endometritis), las trompas de Falopio y los ovarios. El dolor que genera una EPI es normalmente el primer síntoma que nota una mujer. Si existe daño en las trompas de Falopio la primera vez que la mujer siente dolor, este daño es irreversible. La EPI deja cicatrices permanentes y contrae las trompas de Falopio. Esto aumenta el riesgo de un embarazo ectópico de siete a diez veces.

Esta afección podría ser mortal para las mujeres ya que la rotura de las trompas causa una abundante hemorragia. Se estima que los embarazos ectópicos causan entre un 1% y un 5% de todas las muertes maternas.

EPI e infertilidad entre un 55% y un 85% de mujeres con EPI que no reciben tratamiento podría volverse estériles mujeres podrían perder su fertilidad. Muchas sin siquiera darse cuenta que tenían EPI.

Durante el embarazo, una infección por sífilis se podría extender por la placenta e infectar al feto. Hasta un 40% de los embarazos sifilíticos terminan en aborto espontáneo, muerte fetal o muerte perinatal. Esto resulta especialmente grave cuando la infección materna no se trata durante las primeras 20 semanas de embarazo.

La gonorrea en los hombre puede producir complicaciones graves y secuelas. Una infección se puede diseminar desde la uretra (donde se conoce como uretritis) hasta el epidídimo (donde se la conoce como epididimitis). Esto, a su vez, puede causar subfertilidad.

La oftalmía neonatal afecta a un 5% de recién nacido en algunos países en desarrollo. Sin tratamiento, daña la visión ente un 1% y un 6% de los neonatos afectados. La clamidia se podría diseminar a los pulmones del neonato y provocar una neumonía por clamidia.

Todas estas complicaciones se pueden evitar si se administra el tratamiento correcto mucho antes de que se desarrollen las patologías clínicas.

1.7. CÓMO ACTÚAN LOS TRATAMIENTOS Y SU IMPORTANCIA

La mayoría de las ITS son curables con los tratamientos disponibles en el mercado. Las ocasionadas por bacterias se curan con antibióticos específicos, las originadas por parásitos con antiparasitarios y las causadas por hongos con antimicóticos.

Actualmente, para evitar los tratamientos de varios días, que tienen el riesgo de que las personas los abandonen y, por consiguiente, no consigan la curación total, se ha recomendado la utilización de las llamadas dosis únicas: se toma o aplica el medicamento una sola vez.

El tratamiento debe ser llevado a cabo por los dos miembros de la pareja o extenderse a todos los contactos sexuales de la persona a la que se le diagnostica una ITS, con el propósito de romper la cadena de transmisión y prevenir las reinfecciones. Si se llevan a cabalidad los tratamientos según las indicaciones médicas, se evitan también las consecuencias a largo plazo.

1.8. INFECCIONES QUE NO SON CURABLES

Las ITS originadas por virus son tratables y controlables, más no curables; hasta ahora la ciencia no ha podido encontrar una cura definitiva para los virus. Por ello muchas veces las ITS causadas por virus se quedan en el cuerpo de por vida.

En el siguiente cuadro se enlistan estas infecciones y se relacionan según el síndrome a que pertenecen y el agente causal.

SÍNTOMA	INFECCIÓN	AGENTE CAUSAL (MICROORGANISMO)
Secreción o flujo	Herpes simple	Virus herpes simple I y II
Úlceras o llagas	Herpes simple	Virus herpes simple I y II
	Infección por Citomegalovirus	Citomegalovirus(CMV)
Tumoraciones	Condilomas acuminados / Lesiones genitales	Virus del Papiloma Humano (VPH)
Sin síntomas o sintomatología variada	SIDA	Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

1.9. LAS ITS Y EL VIH COMO CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En estudios realizados en muchos entornos de ingresos altos y bajos se ha descubierto que las mujeres seropositivas al VIH tienen mayores probabilidades que otras mujeres de haber sido víctimas de violencia física y sexual1. La violencia puede aumentar la vulnerabilidad de las mujeres a la infección por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual por vías directas e indirectas, por ejemplo (OPS, 2013):

- La violencia infligida por la pareja dificulta que la mujer pueda rechazar una relación sexual o negociar el uso de un condón;
- Las relaciones sexuales forzadas pueden desgarrar la vagina, con lo cual aumenta el riesgo de transmisión del VIH;
- El abuso sexual en la niñez puede aumentar las tasas de comportamientos sexuales de alto riesgo en etapas posteriores de la vida, por ejemplo, un menor uso de condones, múltiples parejas y experiencias adicionales de

violencia;

- El temor a la violencia puede impedir que las mujeres soliciten pruebas de detección del VIH, orientación o servicios, entre ellos los destinados a prevenir la transmisión del VIH a los lactantes.

Según el Estudio sobre el embarazo en la adolescencia en 14 municipios de Bolivia (UNFPA, 2016), adolescentes entrevistadas indican que su primera relación sexual fue una violación. Fueron víctimas de violación a los 10, a los 12 y a los 14 años, en diferentes circunstancias, por personas conocidas y también desconocidas.

"La violencia sexual es una expresión de la disparidad de poderes entre los géneros" y se puede manifestar intragénero (González, 2008). Las y los adolescentes no están exentas/exentos de esta forma de violencia, pues muchas veces se presenta desde las primeras relaciones de pareja, no necesariamente se da fuera de un vínculo afectivo. Asimismo, existen diversas consecuencias de la violencia sexual en la salud de los y las adolescentes, que resumiremos a continuación.

Una de las consecuencias de la violencia sexual en la salud de los y las adolescentes es la infección por VIH u otras ITS.

Es de vital importancia que las maestras y los maestros conozcan las recomendaciones internacionales y nacionales para la prevención de estas infecciones después de una violación sexual:

- La persona debe ser referida de preferencia dentro de las primeras 72 horas, a un centro de salud para recibir atención y tratamiento profiláctico (Ministerio de Salud, 2015).

De manera similar ocurre con la hepatitis B y C, pues en la mayoría de las personas la enfermedad se manifiesta de 15 a 20 años después de que se contrajo la infección y muy frecuentemente esto ocurre en la etapa de la adolescencia.

1.10. EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

VPH es la abreviatura para designar al Virus del Papiloma Humano, el virus causante de las verrugas genitales, condilomas o las llamadas "crestas de gallo".

En la actualidad existen más de 130 subtipos del VPH. La mayoría son inofensivos y son altamente frecuentes en la población general. Pero por lo menos una docena de tipos de VPH pueden permanecer en el cuerpo y, en ocasiones, causar cáncer. Dos en particular (los tipos 16 y 18) provocan la mayoría de los casos de cáncer cervical. Estos tipos se denominan VPH de alto riesgo.

Debido a que el VPH es una infección que en la mayoría de los casos pasa desapercibida, es de alto riesgo ya que puede tratarse de un tipo de VPH que



Sabías que...

Toda mujer que haya iniciado relaciones sexuales necesita realizarse el examen de Papanicolaou y la captura híbrida, para la detección temprana del VPH o de cualquier otra alteración en sus órganos sexuales.

provoque cáncer en el futuro si no es controlado.

Los síntomas y signos de esta infección se hacen presentes de un mes a varios años después de la transmisión. Cuando este virus se hace presente en el cuerpo lo hace a través de pequeñas verrugas, de color carne, que crecen rápidamente y parecen "crestas de gallo".

En el caso de las adolescentes las verrugas se pueden presentar en los labios mayores y menores de la vulva, alrededor o dentro del ano, en la vagina, en el cuello de la matriz y algunas veces en la boca.

En algunas ocasiones este virus no se manifiesta con la presencia de verrugas, sino que se queda en el cuerpo, en etapa de latencia (expresión a nivel celular), que solamente es posible detectar a través del examen de "Papanicolaou" (citología cérvico - vaginal) o la "Captura Hibrida" (Prueba del VPH).

En los hombres adolescentes, estas verrugas se pueden presentar en el pene, en el ano (aunque no hayan tenido relaciones sexuales por esta vía) y ocasionalmente en la boca.

a) Diagnóstico y prevención del cáncer de cuello uterino producido por el VPH

A continuación, se incluyen medidas que se pueden tomar para tener un cuello uterino sano.

1. El examen de Papanicolaou detecta cambios anormales en el cuello uterino para poder tratarlos antes de que se manifieste el cáncer. En general, una mujer se debería hacer el Papanicolaou una vez al año.
2. La Captura Híbrida, es una prueba que detecta los tipos de virus del papiloma humano de alto riesgo que pueden provocar cáncer de cuello uterino. En general, una mujer se debe realizar la captura híbrida cada 5 años. El proceso de la prueba es el mismo que el de Papanicolau: se toman muestras de células del cuello del útero y se envían a un laboratorio para que sean analizadas.
3. También existen procedimientos clínicos como una Colposcopia y la Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA), procedimientos que le ayudan al médico a observar más de cerca el cuello uterino para ver si hay células precancerosas.

4. También podría realizarse una biopsia, un procedimiento que consiste en extraer una pequeña porción de tejido del cuello uterino. El tejido se envía a un laboratorio, donde se analiza para detectar signos de cáncer cuello uterino.
5. Otra forma de prevención es la aplicación de la vacuna contra el VPH. Esta vacuna protege contra los tipos de VPH 16 y 18, las 2 clases del virus que causan la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino.
6. Usar condones cada vez que se tenga relaciones coitales, anales u orales. Esto ayuda a disminuir las probabilidades de transmisión del VPH cuando se tienen relaciones sexuales.

Es recomendable hacerse evaluaciones médicas que incluyan una combinación de pruebas, por ejemplo: el Papanicolaou y de Captura Híbrida. El médico es el único que puede establecer qué pruebas se necesitan y con qué frecuencia se deben hacerlas.

ACTIVIDAD PARA EL AULA

"Consecuencias de las ITS"

Objetivo: Analizar las consecuencias socioeconómicas de las ITS.

Nivel: Secundaria.

Tiempo aproximado: 45 minutos.

Desarrollo:

Los siguientes dos estudios de caso tienen que ver con las consecuencias socioeconómicas de las ITS. Léalos y luego responda a las preguntas que le siguen.

Comparta sus respuestas en grupos de tres personas reflexionando sobre las mismas e identifique conclusiones principales, las cuales serán compartidas en plenaria.

Caso 1: Soledad

Soledad una niña de nueve años, del tercer curso de primaria, acude a la clínica junto a su madre a causa de algunas 'llagas' genitales que había visto la madre el día anterior. No es posible obtener ningún historial significativo, ni de la madre ni de la niña, sobre cómo pueden haber aparecido las 'llagas'. No hay antecedentes de traumatismos. Una doctora examinó a Soledad detrás de un biombo mientras la madre esperaba sentada en la misma habitación. El examen mostró que la niña tenía lesiones rojizas, sucias, de aspecto verrugoso en la zona de la vulva que sugerían condilomas planos de una sífilis secundaria.

Antes de administrar el tratamiento, la doctora a cargo, que tenía experiencia en charlas con niñas y niños, llevó a Soledad a un lado y le habló lejos de la madre. Después de 20 minutos averiguó que un tío (el hermano del padre) habitualmente 'jugaba' con la niña y 'hacía bromas' con ella tocándole la zona genital y haciéndola sentarse en su regazo, aun cuando él estaba medio desnudo.

Él le había dicho que eso era sólo un juego entre él y ella, y que no debía decírselo a nadie más. Se le informó a la madre de este "juego". Ella se mostró muy silenciosa y no parecía sorprendida. Soledad recibió un tratamiento para la sífilis y fue revisada una semana más tarde. Todas sus lesiones habían desaparecido.

La doctora de la clínica habló de la situación con la madre, le informó que se había cometido delito grave de estupro por la violación que sufrió Soledad y que debía informarle sobre el caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Policía).

La madre se negó y dijo que estaría 'mal visto' reportar a un familiar tan cercano a la policía, ya que éste bien podría ir a prisión. ¡Y eso sería muy malo para la familia!

Preguntas para el trabajo (Caso de Soledad):

- ¿Cuál es el rol de la doctora en un caso tan obvio de abuso sexual de menores?
- ¿Está permitido que una doctora informe de la situación a la policía cuando los padres se niegan a presentar cargos?
- ¿Cuáles serían las consecuencias sociales de denunciar al tío a la policía en un entorno como el suyo, si usted fuera la mamá o el papá de Soledad?
- ¿Qué mensaje importante le dejó este estudio de caso?
- ¿Qué se debería hacer desde el ámbito educativo para contribuir en la prevención, detección y atención de niñas, niños y adolescentes que tienen ITS/ VIH o se encuentran en riesgo de contraer ITS/VIH?

Caso 2: Lorena

Lorena, una adolescente de 15 años, le pidió a su maestra no participar de ejercicios físicos que vienen realizando en la clase de educación física, ya que se siente muy incómoda por una secreción vaginal con un olor "particular" que ella tiene, la maestra la regaño y le dijo que informara al director que no quiere pasar clases y que eso le perjudicaría en sus calificaciones.

Lorena preocupada acude al centro de salud para recibir tratamiento en una clínica privada. Ella se quejaba de su secreción vaginal recurrente y del olor "particular" al personal de salud. Lorena admitió que era sexualmente activa y que no siempre usaba condones con su novio. Negó haber tenido múltiples parejas sexuales.

En un examen externo de la vulva, que fue el único tipo de examen que ella aceptaría, ya que no quería un examen con espéculo, el médico notó una pequeña secreción con olor a "pescado". La secreción no era suficiente como para que el médico pudiera identificar el color. Lorena no podía pagar pruebas de laboratorio, por lo cual el médico no pudo siquiera tomar una muestra con un hisopo para examinar la secreción al microscopio.

El médico le sugirió a Lorena que comprara algunos medicamentos para tratar una infección de transmisión sexual conocida como tricomoniasis. El tratamiento se extendería durante cinco días y podría darle náuseas. Ella no contaba con el dinero suficiente para comprar medicamentos costosos, aunque pensó que su novio podría ayudarla.

Sin embargo, como vivía en casa con sus padres y hermanas, no podía tomar ningún medicamento que se extendiera durante una semana, ya que no tendría dónde esconderlo en la casa. Ella no podía decirle a su madre que estaba tomando pastillas, ya que su madre no sabía que ella había concurrido a la consulta de un médico. No podía tener una infección de transmisión sexual porque se suponía que ella no era sexualmente activa a su edad. Además, según su religión, no podía tener relaciones sexuales antes del matrimonio.

Preguntas para el trabajo (Caso de Lorena):

- ¿Qué opina sobre la postura o actuar de la maestra?
- ¿Qué opina usted sobre esta decisión? Lorena se niega a acceder al tratamiento por su duración y porque podría darle náuseas, lo que le revelaría la verdad a su familia.
- ¿Qué debe hacer el médico? Dado que Lorena es menor de edad
- ¿Se debería incluir a los padres?
- ¿Qué rol debería cumplir la unidad educativa en el caso de Lorena?
- ¿Considera que la Educación Integral en Sexualidad puede contribuir y promover vidas saludables y responsables en la vivencia de la sexualidad en adolescentes que se encuentran en similares situaciones de Lorena?

ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO

Tomando en cuenta el área de saber y conocimiento que tiene como maestra o maestro, analizar e identificar **una manera integral** de incorporar en la Planificación Trimestral el contenido que se desarrolló.

BICENTENARIO DE BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Tema 2

VIH/SIDA

UNEFCO
Unidad Especializada de Formación Continua

ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO

Antes de empezar el desarrollo de la temática es necesario hacer un análisis de la información que se tiene, respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Quiénes se enferman de VIH?

.....
.....
.....

¿Cómo se transmite el VIH?

.....
.....
.....

2.1. LA EPIDEMIA DEL VIH/SIDA

La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es la que causa el SIDA, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El SIDA es una enfermedad que se desarrolla en la última etapa de infección del VIH y que destruye progresivamente las defensas del cuerpo contra las enfermedades. La infección por VIH se transmite a través de las mismas conductas que otras ITS.

A diferencia de la mayoría de los virus, el VIH actúa en forma lenta y tarda años en producir la enfermedad. Durante alrededor de diez años, las defensas inmunológicas de una persona infectada por VIH se debilitan gradualmente. Una variedad de bacterias, virus, hongos y parásitos, conocidos como patógenos "oportunistas", se aprovechan de la situación para causar enfermedades. Las personas infectadas con el VIH son "seropositivas".

Cuando el VIH entra en el cuerpo, ataca al sistema inmunológico, el cual normalmente protege el cuerpo contra infecciones. Con el tiempo, el organismo de una persona con el virus se vuelve incapaz de luchar contra las infecciones e inclusive contra las enfermedades comunes que en otras circunstancias no serían graves. Cuando el organismo ya no puede defenderse contra estas enfermedades, la persona tiene SIDA.

Por el momento no existe una vacuna para prevenir la infección por VIH y no existe cura para el SIDA una vez que se ha contraído. Toma bastante tiempo notar los síntomas del virus, así que una persona con el virus puede parecer sana por muchos años y no saber que tiene el VIH. Durante este tiempo, puede infectar a otras personas sin saberlo. De hecho, durante las tres semanas después de haberse infectado por VIH, una persona es altamente infecciosa y puede transmitir el virus con mucha facilidad (fase de infección aguda), con el agravante que, en este periodo de tiempo, la persona infectada no sabe que es VIH positiva. Pasadas las tres semanas, se pasa a la fase de

infección asintomática, que puede durar meses o años, y en la que se reduce la capacidad infecciosa.

El período de tiempo que le toma a una persona desarrollar señales de la presencia del VIH depende del estado de su sistema inmunológico y de la agresividad del tipo de virus. No todas las personas infectadas por el VIH presentan la enfermedad del SIDA, aunque muchas desarrollan la enfermedad a la larga. Lo más frecuente es que si no ha recibido tratamiento, al cabo de unos cinco o diez años, una persona infectada por el VIH padezca los síntomas de la enfermedad. Como el virus ataca al sistema inmunológico del organismo y hace que la persona se vuelva más vulnerable a infecciones, los síntomas varían mucho dependiendo de la infección o enfermedad que desarrolla la persona

Algunos de los síntomas más comunes son:

Inflamación de las glándulas linfáticas

Severa pérdida de peso y fatiga.

Sudoración, especialmente en la noche.

Fiebres recurrentes.

Diarrea severa y persistente.

Náusea y vómito.

Tos persistente.

Salpullido en la piel y llegas en la boca.

Aunque no existe cura para el VIH, hay algunas medicinas que ayudan a las personas a vivir con el VIH por muchos años sin enfermarse y que mejoran la calidad de vida de las personas que ya han desarrollado el SIDA. Es el caso, por ejemplo, de los antirretrovirales (ARV): estos medicamentos impiden la progresión del virus (aunque no lo elimina). La eficacia de los ARV en el tratamiento del SIDA ya es ampliamente reconocida. Estos medicamentos están disponibles en nuestro país el Ministerio de Salud, dispone de ARV.

El SIDA es una enfermedad que afecta la vida de muchas personas y, por lo tanto, los gobiernos deben asignar fondos para garantizar que sus ciudadanos afectados puedan ejercer el derecho a acceder a los medicamentos y últimos avances de la tecnología científica. Las personas con VIH o SIDA tienen muchas necesidades. Éstas incluyen terapias para el tratamiento de infecciones oportunistas, así como también fármacos antirretrovirales que atacan al mismo VIH. Además, necesitan apoyo para poder enfrentar el miedo a la estigmatización, apoyo psicológico para poder sobrellevar las consecuencias de esta enfermedad que pone en riesgo la vida, y apoyo social y orientación.

2.2. ¿QUÉ ES EL VIH?

El Virus de Inmunodeficiencia Humana conocido como VIH agrede el sistema de defensas del cuerpo o sistema inmunológico, es decir disminuye la capacidad de los glóbulos blancos/Linfocitos CD4 que son los encargados de defender al cuerpo de una infección o enfermedad.

Revisemos primero como funciona nuestro sistema inmunológico. Este es el conjunto de defensas que nuestro cuerpo tiene para evitar la entrada de microorganismos y las enfermedades en general. Involucra a varios órganos del cuerpo humano como a la médula ósea y el sistema linfoide. Los glóbulos blancos son los actores principales.

Cuando un microorganismo patógeno entra en el cuerpo, los macrófagos, un tipo de glóbulos blancos, se encargan de comérselo y memorizan sus identificaciones genéticas para trasmitirlas a las células T (otro tipo de glóbulos blancos) para que éstos a su vez, activen a los linfocitos CD4 que son los glóbulos blancos que producen los anticuerpos, para que, en caso de invasión posterior, la respuesta del sistema inmunológico sea rápida y específica.

Los virus que producen enfermedades, como el de la gripe, son capaces de infectar a una célula de un organismo superior y replicarse utilizando las células de ese organismo huésped. El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un virus muy pequeño, imposible de ver a través de un microscopio común, muy frágil, pues muere a una temperatura superior a los 56° centígrados. Para reproducirse, el VIH entra en las células T de nuestro sistema inmunológico a las cuales cambia el código genético para que, en lugar de defender al organismo, produzca más virus. Así mismo las células T no pueden actuar como jefes y dejan al cuerpo sin protección de las enfermedades. El VIH entra al organismo humano de una persona sana por el contacto de una persona infectada con el virus. Ya sea a través de la sangre, del semen, de los fluidos vaginales o por la leche materna.

2.3. LA RELACIÓN ENTRE LAS ITS Y EL VIH/SIDA

La interrelación entre las ITS y el VIH es más compleja, en el sentido que:

- Ciertas ITS facilitan la transmisión del VIH.
- La presencia del VIH puede hacer a las personas más susceptibles a contraer una ITS.
- La presencia del VIH aumenta la gravedad de algunas ITS y su resistencia al tratamiento.

¿Cuáles son las ITS que parecen facilitar la transmisión del VIH?

Una persona con llagas abiertas en la zona genital es mucho más propensa a contraer y transmitir el VIH. El chancroide y la sífilis son las principales causas bacterianas de llagas. Si se diagnostican y se tratan de forma inmediata, estos vínculos se pueden reducir.

El herpes genital también facilita la transmisión del VIH. "Existe evidencia de que el herpes genital, una infección viral que no tiene cura, en la cual las y los pacientes presentan úlceras genitales recurrentes, podría jugar un papel más importante en la transmisión del VIH" (ONUSIDA, 2000). La clamidia, la gonorrea y la tricomoniasis también pueden facilitar la transmisión del VIH. Esto puede ser a causa de una o dos razones:

Estas enfermedades no ulcerosas estimulan el sistema inmunológico del organismo para aumentar el número de leucocitos, que son tanto objetivos como fuentes del VIH.

La inflamación genital asociada con estas ITS puede causar cortes microscópicos en los tejidos genitales y crear así sitios potenciales por donde el VIH puede ingresar al organismo.

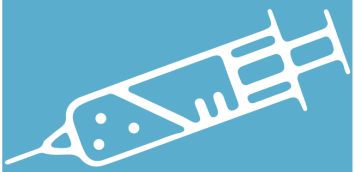


También es cierto que las personas infectadas con VIH son más vulnerables a contraer infecciones múltiples. Esto se debe a que los cambios corporales que atraviesan los hacen más vulnerables a las infecciones en general.

"Un vínculo adicional entre el VIH y otras ITS es la alteración de la evolución de una ITS en un individuo con inmunodeficiencia concomitante asociada al VIH. La gravedad de las manifestaciones podría aumentar, la infectividad podría prolongarse e incrementarse, y la respuesta a los regímenes convencionales podría reducirse" (ONUSIDA/OMS. 1999)

2.4. FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH

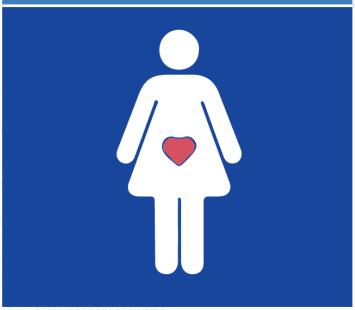
Es importante recordar que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se transmite de la misma manera que cualquier otra ITS:



Contacto directo con la sangre infectada con el VIH, incluyendo agujas, accidentes de trabajo en el área de la salud y ciertos productos derivados de la sangre (en algunos países la transfusión de sangre todavía es considerada un factor de riesgo), en el caso de países como El Salvador la transmisión por esta vía ya no se ha registrado, la sangre es examinada con mucho rigor por lo que no se considera un factor de riesgo.



Contacto sexual sin protección con personas infectadas con el VIH entre un hombre y una mujer, o entre personas del mismo sexo.



De madre a bebé (durante el embarazo, el parto y en el periodo de lactancia materna, cuando la madre está infectada).

2.4.1. ¿Cómo ocurre la transmisión del VIH por vía sanguínea?

La transmisión por vía sanguínea tiene lugar cuando la sangre de una persona infectada con el VIH entra en el torrente sanguíneo de otra persona. Esto puede ser por el uso compartido de agujas (tatuajes, pearcing...) objetos cortantes y enseres personales (cuchillas de afeitar, cepillo de dientes...) contaminados por el VIH.

Compartir agujas para inyectarse: Esta es una conducta de muy alto riesgo ya que una aguja puede pasar sangre directamente de una persona al torrente sanguíneo de otra, es una manera muy eficiente de transmitir un virus.

2.4.2. ¿Cómo ocurre la transmisión por vía sexual?

La transmisión sexual del VIH se produce en las siguientes relaciones sin protección:

1. Penetración vaginal o anal.
2. Relación buco-genital (sobre todo entran en riesgo si hay lesiones en la boca o en los genitales, se ingieren las secreciones o se mantienen en la boca).

La transmisión se realiza a través del contacto de fluidos: sangre - sangre, sangre-semen o secreciones vaginales.

Durante las prácticas sexuales, normalmente, se producen pequeñas lesiones o heridas microscópicas en las mucosas de la vagina, pene o ano. A través de estas pequeñas aberturas el virus puede pasar a la sangre. Por lo tanto, todas

las prácticas sexuales que favorecen las lesiones y las irritaciones conllevan un aumento del riesgo de transmisión.

La mucosa rectal es más frágil que la mucosa vaginal, por lo que es más fácil que se produzcan lesiones en la penetración anal.

El riesgo se incrementa si se mantienen relaciones sexuales mientras se sufre alguna otra infección de transmisión sexual (porque provocan la aparición de úlceras o llagas en los genitales).

Una sola práctica sexual de riesgo puede bastar para transmitir el VIH. No obstante, la posibilidad de contraer la infección aumenta con el número de veces.

Tanto el hombre como la mujer pueden transmitir el virus a sus parejas. En la mujer infectada con el VIH el periodo de la menstruación es más infeccioso a causa del flujo de sangre.

"La posibilidad de infección de hombre a mujer es mucho más alta que la posibilidad de mujer a hombre".

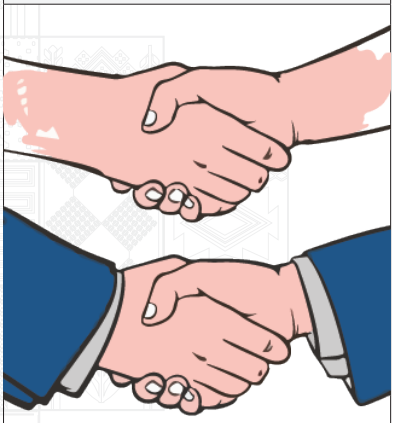
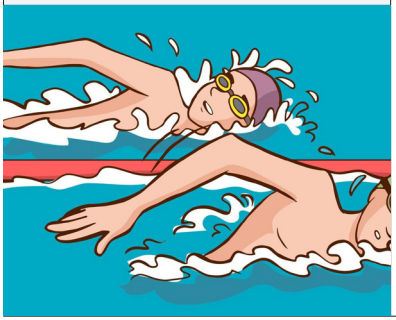
2.4.3. ¿Cómo ocurre la transmisión por vía materno perinatal?

Una mujer infectada con VIH puede transmitir el virus por vía sanguínea durante el embarazo (a través de la placenta) o por el canal del parto. También a través de la leche materna se puede transmitir el virus. Las y los bebés de madres infectadas con el VIH nacen con los anticuerpos del VIH, esto no quiere decir que estén infectadas o infectados por el virus.

El análisis de VIH a las mujeres embarazadas disminuye el número de niñas y niños con VIH debido a la transmisión perinatal y si resultan positivas, deben recibir tratamientos que puedan disminuir significativamente el riesgo de transmisión del VIH al recién nacida/ nacido.

- El grado de transmisión perinatal puede ser reducido considerablemente si las mujeres saben que son VIH positivos y reciben los tratamientos apropiados para prevenir la transmisión.
- La transmisión perinatal del VIH continúa ocurriendo en las mujeres que no reciben cuidado perinatal o prenatal y en las que no se les ofrece una prueba voluntaria del VIH.
- La mayoría de las infecciones perinatales de VIH pueden ser atribuidas a la falta de análisis del VIH y tratamiento a tiempo de las mujeres embarazadas y los bebés.

2.5. MANERAS EN LAS QUE NO SE TRANSMITE EL VIH

Situación	Descripción
Picaduras de insectos. 	El VIH no es transmitido por mosquitos, moscas, chinches, pulgas, abejas o avispas. Si un insecto que chupa sangre, pica a una persona con VIH, el virus muere inmediatamente en el estómago del insecto (a medida que digiere la sangre). El VIH sólo puede vivir en las células humanas.
Contacto casual/Compartir alimentos o utensilios. 	El VIH no se transmite a través del contacto diario y casual: Al no transmitirse por la saliva, es imposible contraer el VIH al compartir vasos, tenedores, un sándwich, pan, una fruta o cualquier otro alimento. Dar la mano, abrazar o besar. Toser o estornudar. Utilizar un teléfono público. Ir al hospital. Abrir la puerta. Utilizar fuentes de agua potable. Utilizar lavados o duchas.
Nadar en piscinas y bañeras/ tinas. 	Las sustancias químicas que se usan en las piscinas y en las tinas matan al VIH instantáneamente, el agua caliente y el tiempo en si los matan también.

Situación	Descripción
Contacto con saliva, lagrimas, sudor, heces u orina  	• La transmisión sólo puede ocurrir cuando una gran cantidad de VIH ingresa al torrente sanguíneo a través de cortaduras o de membranas mucosas. • Estos "fluidos corporales" no contienen VIH o la cantidad de VIH es muy pequeña como para resultar en infección. • El VIH no se transmite mediante la saliva. Hay mucha evidencia que apoya dicha información. • Estudios recientes sugieren que la saliva contiene una enzima que mata el VIH. • Por cierto, muchas cosas suceden en la boca que la transforman en un lugar "desagradable" para el virus: ácidos, enzimas, fricción, dilución, aire y mucho más.

¿Sobrevive el VIH fuera del cuerpo?

Cuando la gente pregunta: "¿Por cuánto tiempo puede sobrevivir el VIH fuera del cuerpo?", muchas veces es porque han entrado en contacto con algún fluido que creen que puede contener el VIH y tienen miedo de haberse infectado.

Casi siempre estas preguntas son acerca de un contacto casual, y sabemos que el VIH no se transmite excepto durante relaciones sexuales sin protección, compartiendo agujas o mediante la exposición importante y directa a sangre infectada.

2.6. PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DEL VIH

Para determinar si una persona está infectada con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, es necesario efectuar una prueba de sangre denominada Prueba ELISA, la cual permite detectar la presencia de anticuerpos contra el VIH, lo que indica que la persona tiene el virus en su organismo.

Sin embargo, antes de las 12 semanas después de la infección, es poco probable que la infección sea detectada por pruebas de laboratorio. A ese período, se le llama PERÍODO DE VENTANA.

Este período es el tiempo que demora el cuerpo en producir cantidades medibles de anticuerpo después de la infección. No se debe dejar de lado

que en este periodo la persona ya es seropositiva y puede transmitir el virus a otra persona. No es posible saber por la apariencia física de una persona si es portadora de VIH, porque el virus puede permanecer en el cuerpo por muchos años sin causar síntomas, a ese período se le llama asintomático.

Solamente con exámenes de sangre en laboratorio, se puede saber si se es o no portador(a) del VIH.

Período de ventana (de 2 a 12 semanas).

El resultado del test ELISA es no reactivo. Sin embargo, la persona está infectada, es decir, puede transmitir el VIH a otras personas. Después de este período, las pruebas de laboratorio pueden detectar los anticuerpos producidos por el cuerpo. La persona vive con el VIH.

Período asintomático Sin síntomas (puede durar desde 6 meses a 10 años o más).

La persona luce sana y no presenta síntomas y puede presentar crecimiento de ganglios linfáticos, llagas en la boca o sudores nocturnos en algunos casos.

Inicio de síntomas. (Puede iniciarse desde algunos meses hasta algunos años después de la infección).

Enfermedades oportunistas, como son la tuberculosis o la neumonía, pérdidas de peso inexplicables, fiebres, diarreas, tos por más de un mes, crecimiento de los ganglios linfáticos, infecciones graves de la piel o recurrentes y en algunos casos la muerte.

El desarrollo del virus.

Después de 15 días a un mes de haberse infectado, algunas personas pueden presentar malestares como de gripe, pero es pasajero. Algunas personas seropositivas pueden pasar de 5 a 15 años sin presentar síntomas, pero generalmente esto ocurre con las personas que presentan un estilo de vida saludable.

Otras pueden presentar síntomas antes de los 5 años. Una persona tiene VIH avanzado, cuando el VIH ha causado suficiente daño al sistema inmunológico y no ofrece resistencia a infecciones llamadas oportunistas, como, por ejemplo, la tuberculosis, las infecciones por hongos y otros microorganismos, la neumonía, la diarrea y lesiones en la piel, entre otras, que terminan por causarle la muerte.

En la actualidad no existe vacuna ni cura contra el VIH avanzado, solamente medicamentos llamados antirretrovirales que contribuyen a mejorar la calidad de vida y permiten hablar de enfermedad crónica y ya no de enfermedad mortal, cuando son ingeridos de acuerdo con las indicaciones médicas y se viva con un estilo de vida saludable. El inconveniente es que son caros y presenta efectos secundarios en ocasiones indeseables.

Hasta la fecha no se han podido fabricar vacunas contra el VIH, porque el virus siempre está mutando, es decir se modifica constantemente. Las enfermedades oportunistas que se han mencionado se curan con medicamentos, pero no el SIDA. Por esa razón es importante utilizar antirretrovirales que reducen la multiplicación del virus en las personas infectadas, lo que prolonga y mejora la calidad de la vida, permite que la persona infectada se reinserte en el campo laboral, social y familiar y se reduzca la presencia de enfermedades oportunistas.

El significado de un resultado negativo y positivo para la prueba del VIH:

Resultado	Descripción
Positivo	Indica que la prueba detectó anticuerpos contra el VIH en la muestra de sangre. Entonces se expresa que esta persona es "seropositiva" (sero: corresponde a suero). En ese caso será necesario comprobar el resultado con una nueva prueba confirmatoria conocida como Western Blot. Es extremadamente importante que un médico capacitado o un psicólogo sea quien entregue este resultado, porque recibir un resultado positivo no significa que el afectado tenga SIDA, o que pronto alguien se vaya a morir, ni que deban evitarse las relaciones sexuales o que no se pueda continuar con una vida normal. No significa que la persona tenga SIDA porque este diagnóstico lo hace un médico/médica utilizando los criterios de los Protocolos de atención de personas con VIH en cada país. Para cualquier prueba debe realizarse orientación previa y posterior a la prueba de acuerdo con la norma y protocolo establecidos nacionales. **Es necesario recordar que para que el VIH progresa a sida pueden pasar algunos años. Sin embargo, existen y se han desarrollado nuevos medicamentos y tratamientos y con éstos las personas con la infección provocada por el VIH pueden vivir saludables por más tiempo.**
Negativo	Indica que no se encontraron anticuerpos contra el VIH en la muestra de sangre tomada, lo que significa que la persona no está infectada. Aunque también es posible recibir un resultado negativo si la prueba se aplica poco tiempo después de considerar haber sido infectado, ya que el organismo aún no ha desarrollado anticuerpos contra el VIH.

Resultado	Descripción
Negativo	Es necesario entonces esperar tres meses después de que se crea que pudo haber ocurrido la infección. El hecho de recibir un resultado negativo significa que no se está infectado y que se deben adoptar o seguir adoptando las medidas de prevención necesarias para no contraer la infección por VIH, pero no que se esté libre de contraer la infección por VIH y de que no haya necesidad de preocuparse por el tema.

2.7. VIVIR POSITIVAMENTE CON EL VIH.

Si una persona descubre que está infectado/infectada con el VIH puede aprender a llevarlo bien, aunque no sea fácil. Los servicios de orientación de los centros de salud pueden ayudar mucho. Es una buena idea contarle la situación a una persona de confianza para no lidiar a solas con la situación.

En muchas personas la enfermedad progresa muy despacio y si se cuidan bien pueden vivir con el virus durante muchos años sin graves problemas. Ante el VIH es muy importante procurar vivir de manera positiva. Mantener una actitud positiva ante la vida nos ayuda a permanecer saludables.

Vivir de manera positiva con el VIH significa:

- Informar a la pareja sexual que se tiene el VIH (es posible que la persona que vive con VIH necesite el acompañamiento de un profesional para poder dar este paso).
- Comer alimentos nutritivos como verduras, frijoles y pescado, que ayudan al sistema inmunológico.
- Tratar todas las enfermedades a medida que surgen.
- Descansar mucho y hacer ejercicio moderado.
- Compartir con otras personas que viven con el VIH, o unirse a grupos de apoyo.
- No tomar alcohol ni fumar.
- Practicar relaciones sexo-coitales seguros (o sea, usar siempre el condón) para no infectar a nadie ni exponerse a la re-infección. Es importante ayudar a otras(os) a vivir positivamente con el VIH. Las personas que viven con el VIH no son "víctimas" y al igual que el resto de las personas tienen mucho que ofrecer.

Las personas que viven con el VIH pueden trabajar y contribuir al desarrollo de la sociedad igual que todos. Necesitan la atención como todas las personas de sus amigos y familiares. Es muy importante ser atento/atenta con las personas que viven con el VIH. Jamás uno debe burlarse ni marginar a una persona por tener la infección.

2.8. EL VIH, LOS DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

Todas las personas tenemos derechos y debemos ejercerlos y defenderlos, en cualquier situación. Ejemplo de ellos:

- Derecho a la igualdad: nadie puede estar sometido a situaciones de discriminación. Si hemos adquirido el VIH, debemos luchar contra todas las ideas negativas que están asociadas al virus.
- También, la discriminación existente en la sociedad puede hacer que algunos grupos estén más expuestos al VIH que otros, como las mujeres, pues existe menos acceso a la educación e información sobre sexualidad; y las personas jóvenes, no cuentan con un acceso igualitario a los servicios del sistema de salud.
- Derecho a la privacidad, incluyendo la confidencialidad de las pruebas del VIH. Contar un estatus de VIH debe ser una decisión individual y responsable.
- Derecho a la información y educación: la información para prevenir el VIH debe estar disponible para todas las personas. Esta información no puede estar parcializada u ocultar datos sobre los métodos disponibles para prevenir la infección de VIH.
- Derecho a decidir tener o no hijos/hijas y el momento adecuado para tenerlos, incluyendo el derecho de las mujeres VIH positivas a continuar o no con un embarazo.
- Derecho a la participación política, para defender los derechos como persona viviendo con VIH. Nadie deja de tener derechos o deja de ejercerlos por haber contraído VIH, las personas somos iguales ante la ley.
- Si tienes VIH o conoces a alguien que lo tenga ¡Infórmate!
- Las personas con VIH pueden hacer una vida absolutamente normal pero deben tomar algunas medidas para mantenerse saludables y mejorar su calidad de vida.

ACTIVIDAD PARA EL AULA

"La vulnerabilidad ante la transmisión del VIH"

Objetivo: Promover la percepción de riesgo frente al VIH.

Nivel: Secundaria.

Tiempo aproximado: 90 minutos.

Materiales:

Preparar una tarjeta para cada participante. Una de las tarjetas ha de tener una "E" en la parte de atrás, que representa a una persona infectada con VIH. Esta tarjeta debe entregarse a una persona que cuente con los recursos personales suficientes y que de ninguna manera pueda quedar estigmatizada a partir del juego. Un 25% de las tarjetas debe tener la Letra "C": que representa que han tenido una relación coital con una persona que tiene una ITS, pero han utilizado condón. Un 50% una "O": representa que han tenido una relación sexual que no ha incluido la penetración y/o no se han infectado. El resto la letra "N" han mantenido relaciones sexuales sin ninguna medida de protección.

Desarrollo:

1. Distribuir una tarjeta a cada participante. Explicar que tras el debate cada uno deberá escribir su nombre en la tarjeta de la respectiva pareja de debate.
2. Invitar a ponerse de pie y mezclarse, eligiendo una persona con quien debatir sobre "la influencia que ha tenido la aparición del VIH/SIDA en la vida de los adolescentes".
3. Tras 5 minutos, cada persona debe escribir su nombre en la tarjeta de su interlocutor (pareja de debate) y buscar una nueva pareja con la que debatirán el mismo tema. Esto se repetirá 5 veces.
4. Tras el quinto intercambio, cada persona se sentará en su sitio.
5. Se invita a levantarse a la persona que tenga la letra "E" en la parte posterior de su tarjeta: esta persona representa a una persona que vive con el VIH.
6. A continuación, se levantarán todas aquellas personas que tengan el nombre de la persona que vive con VIH en sus tarjetas: también han podido resultar infectadas.
7. Posteriormente deben levantarse quienes tengan los nombres de todas las personas anteriores en sus tarjetas: también han podido resultar infectadas.

8. Indicar que las personas que están de pie y tengan la letra "C" en la parte posterior de sus tarjetas pueden sentarse ya que han tenido una relación coital con una persona que tenía una ITS, pero ¡han utilizado condón!
9. Las personas que estando de pie tienen una "O" en sus tarjetas pueden sentarse. ¡Han tenido una relación sexual que no incluido la penetración y no se han infectado!
10. Finalmente, las personas que permanecen en pie se han expuesto al riego de contraer VIH y pueden haberse infectado. La Letra "N" de las tarjetas significa "ninguna medida de protección". Deben recordar que, aunque no es muy probable, es suficiente una única relación coital para infectarse.

Preguntas para el debate:

- ¿Cómo se siente uno cuando contrae VIH?
- ¿Cómo se siente cuando uno no ha contraído VIH porque ha usado condón?
- ¿o por qué se han mantenido relaciones sexuales sin penetración?
- ¿A qué se debe que solo el 25% de las personas hayan utilizado condón, a pesar de la información que tenemos sobre la transmisión del VIH y de otras ITS?
- Se debe observar que un 50% de los participantes no realiza prácticas sexuales con penetración.
- ¿Qué piensan de eso?

Nota:

Antes de empezar el debate explicar que sólo ha sido un juego, y que ninguna ITS o el VIH se transmite por hablar con una persona infectada.

ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO

Dentro el accionar educativo y la experiencia desarrollada como maestra o maestro, identificar el contenido que no sé está aplicando en aula

Planificar el desarrollo del contenido relacionado al VIH/SIDA de manera integral.

BICENTENARIO DE BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Tema 3

PREVENCIÓN DE LAS ITS/VIH/SIDA

UNEFCO
Unidad Especializada de Formación Continua

ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO

Para iniciar el presente tema se hace necesario desde nuestra experiencia personal reflexionar:

¿Por qué es tan difícil el control de las ITS?

.....
.....
.....

3.1. EL DESAFÍO DE PREVENIR LAS ITS/VIH/SIDA

Los objetivos de la prevención y el tratamiento de ITS son la reducción de la prevalencia de las ITS mediante la interrupción de la transmisión, la reducción de la duración de la infección y la prevención del desarrollo de complicaciones en las personas infectadas. Pero el control resulta difícil por muchas razones. De hecho, existen muchos desafíos a considerar:

a) Factores relacionados con el sistema de salud:	Los servicios de salud que tienen la capacidad de diagnosticar y tratar las ITS podrían: • No estar disponibles o estar muy lejos. • Ser muy costosos. • Estigmatizar a aquellos que los visitan. Existe muy poco énfasis en los esfuerzos educativos y de otra índole para prevenir la infección. Los servicios de salud también podrían no ser aptos para ofrecer a la o el paciente los medicamentos más efectivos, generalmente debido a su costo relativo. Una creciente resistencia a los fármacos en muchas áreas demanda el uso de fármacos cada vez más caros para lograr el control. El tema del costo puede ser fundamental en la decisión de las y los pacientes de consultar proveedores de salud.
b) Factores biológicos	Entre un 70% y un 80% de las mujeres infectadas podrían ser asintomáticas y, por ende, no buscarían tratamiento. Esto también se aplica a una minoría significativa de hombres. Estas personas continuarán estando infectadas, arriesgándose a las complicaciones y, quizás, infectando a otros.

c) Factores sociales y conductuales:	Los factores sociales para tener en cuenta son muchos: • La resistencia a buscar atención médica. Esto podría ser por muchas razones, dentro de las que se incluyen la ignorancia, la vergüenza o la culpa. • La información errónea. Estos poderosos obstáculos existen en todos los grupos de edad y en todos los tipos de personas y tienden a difundirse entre los adolescentes y los jóvenes, quienes suelen ser más sexualmente activos. • Las prácticas sexuales están muy arraigadas en la vida cotidiana de las personas y sus comunidades. • Una preferencia por las prácticas de salud alternativas, como los curanderos tradicionales. • Una resistencia a seguir las prácticas sexuales seguras por distintas razones, que incluyen: la falta de conocimiento sobre el sexo seguro; la falta de aceptación del uso de los condones. • El estigma social que está frecuentemente asociado con las ITS. Esto podría significar que las personas esconden aquello que sienten como vergonzoso y, por lo tanto, evitan buscar algún tipo de tratamiento. • El hecho de no poder finalizar un tratamiento prescrito para una ITS, por varias razones: - Por requerir un curso de varios días. - Los síntomas de las y los pacientes desaparecen, haciéndoles creer que la infección está curada y que pueden guardar' los medicamentos para otro momento u otras personas. - La dificultad que implica informar a las parejas sexuales debido al miedo, la vergüenza o la falta de conocimiento sobre las consecuencias.

d) Factores relacionados con el ámbito educativo:	Las unidades educativas son el escenario clave para educar a las y los estudiantes sobre el VIH/sida y para evitar que se propague la infección del virus. El éxito de esta tarea depende de: • Un acercamiento oportuno a las y los adultos jóvenes, para reforzar conductas positivas de salud y modificar las conductas que ponen en riesgo a las y los jóvenes. • Contar con maestras y maestros calificados. • Posibilitar el desarrollo de procesos educativos e interactivos con información científica libre de prejuicios, que propicien la participación y el aprendizaje activo. • Capacidad de involucrar a los padres en el proceso de aprendizaje. • Establecer alianzas dentro de la unidad educativa y de la comunidad. • Adaptar los métodos de enseñanza tanto para los hombres como para las mujeres estudiantes, de manera que se transversalice el enfoque de género. Una nueva iniciativa, llamada Recursos Enfocados a la Salud Escolar Eficaz (FRESH, por sus siglas en inglés), fue dada a conocer en el Foro Mundial de la Educación en Dakar, Senegal (abril de 2000). Patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial. Dicha iniciativa señala los cuatro pilares necesarios: 1. Políticas claras de salud educativa respecto a la discriminación por VIH/SIDA 2. Un ambiente sano. 3. Educación basada en habilidades para la prevención del VIH/SIDA. 4. Asesorías desde las unidades educativas y clubes estudiantiles para prevenir el VIH/SIDA. El revertir el curso de la epidemia de VIH/SIDA es una meta del sector educativo con un abordaje integral e intersectorial. Es un reto abordar el tema y necesita el desarrollo capacidades que debe ser asumida por el sistema educativo y a nivel personal.

3.2. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ITS/VIH/SIDA

Todas las ITS, incluido el VIH, se pueden prevenir. La prevención puede ser primaria o secundaria:

- La prevención primaria apunta a evitar que las personas contraigan una ITS o el VIH.
- La prevención secundaria se trata de la provisión de tratamiento y atención a las personas infectadas para evitar que continúe la transmisión a otras personas.

3.2.1. Prevención primaria

Se trata de adoptar una conducta sexual más segura y mantener sólo contactos sexuales seguros.

Una conducta sexual más segura implica:

1. Abstinencia total de la actividad sexual.
2. Retraso en la edad de la iniciación sexual.
3. Monogamia mutua de por vida.

Estas son las tres formas de evitar las ITS/VIH/SIDA

Una actividad sexual más segura implica:

- Participar sólo en actos sexuales sin penetración: masturbación mutua y fricción de las partes del cuerpo.
- Participar en actos sexuales con penetración sólo si se utilizan condones (femeninos o masculinos). Los actos sexuales con penetración incluyen el sexo vaginal, oral y anal.

3.2.2. Prevención secundaria

Esto se puede lograr mediante:

- La promoción de una conducta relacionada con la búsqueda de atención para las ITS, a través de las campañas de educación pública.
- La disponibilidad de establecimientos de salud que no estigmaticen y no discriminen.
- El ofrecimiento de una atención de calidad para ITS.
- La garantía de un suministro continuo de fármacos altamente efectivos.

- La garantía de un suministro continúo de condones.

• Un tratamiento rápido y efectivo para las personas con ITS:

- Manejo integral de casos de síndromes de ITS; capacitación de los proveedores de salud en el manejo de casos.

Hallazgo de casos:

• Examinar a las mujeres mínimamente sintomáticas que asisten al servicio de salud en busca de atención materno-infantil y de anticoncepción.

• Notificación y tratamiento de la pareja.

• Educación, investigación y tratamiento de grupos específicos de la población que podrían haberse expuesto al riesgo de infección, como las trabajadoras sexuales, los conductores de camiones de larga distancia, las personas que trabajan en el servicio militar y los jóvenes, tanto dentro como fuera de la unidad educativa.

3.2.3. Atención integral en los centros de salud

Comprende seis características:

1. Realizar un diagnóstico correcto.
2. Administrar la terapia antimicrobiana correcta para el síndrome de ITS.
3. Educar a la o el paciente sobre la naturaleza de la infección, conductas sexuales más seguras, actos sexuales seguros y la reducción del riesgo para poder prevenir o disminuir conductas de riesgo en el futuro.
4. Educar a la o el paciente sobre el cumplimiento del tratamiento.
5. Demostrar el uso correcto de condones y proveer condones.
6. Orientar para que las parejas de los o las pacientes reciban tratamiento y emitir boletas de referencia para que el o la paciente la entregue a su(s) pareja(s).

3.3. LAS RELACIONES SEXUALES SEGURAS

Las relaciones sexuales seguras son las prácticas sexuales que reducen significativamente los riesgos de contraer una ITS, incluyendo el VIH, o de causar un embarazo.

• No tener relaciones sexuales o practicar la abstinencia sexual en pareja reduce el riesgo de contraer una ITS y el VIH, y obviamente, anula cualquier probabilidad de embarazo.

• El autoerotismo es también una práctica sexual poco riesgosa. Practicar la masturbación con nuestra pareja también es bastante seguro. Sólo hay posibilidad de infección por VIH si tenemos algún corte o llaga abierto en las manos y entramos en contacto con los genitales o fluidos corporales de una persona con el VIH.

Imagen 1: Métodos de planificación familiar



Fuente: https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/2614399-salud-sexual-metodos-de-planificacion-familiar-set-icons-line-fill-blue

- Besar y abrazar a la pareja también es seguro. No existen casos de transmisión del VIH por besarse o abrazarse. Sin embargo, si una persona estuviera infectada con el VIH y tuviera llagas abiertas en la boca, podría existir una posibilidad mínima de infección.
- La relación sexual entre dos personas que están libres del VIH también es segura, aunque igualmente se debe utilizar un método anticonceptivo para evitar un embarazo.
- El uso del condón: cuando se usa de forma correcta y consistente, se proporciona muy buena protección contra las ITS, incluyendo el VIH, y contra los embarazos. El condón evita que las bacterias y virus de la vagina entren en contacto con el pene y protege también a la mujer de los virus y de las bacterias contenidos en el semen.

3.4. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ITS/VIH/SIDA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La vulnerabilidad está relacionada con factores que reducen la capacidad de las personas o comunidades para evitar las ITS/VIH/SIDA, lo que incluye:

- **Factores personales,** como falta de los conocimientos y aptitudes necesarias para protegerse y proteger a otros.
- **Factores relativos a la calidad y cobertura de los servicios,** como inaccesibilidad debido a la distancia y costo entre otros.
- **Factores sociales, normas culturales, religiosas, prácticas, creencias y leyes** que estigmatizan y limitan a ciertas poblaciones y actúan como barreras para mensajes esenciales de prevención de las ITS/VIH/SIDA.

Estos factores, por sí solos o en combinación, incrementan la vulnerabilidad individual, de un grupo o de una comunidad.

3.4.1. Niñez

En Bolivia hay niñas y niños infectados con ITS/VIH. Estos se han infectado por transmisión perinatal y por haber sido víctimas de abuso sexual. La transmisión perinatal de ITS/VIH es prevenible. Se requiere que la madre acuda al control prenatal y sea diagnosticada a tiempo para recibir el tratamiento indicado durante el embarazo, el parto y que no lacte para que él o la bebé esté libre del VIH.

Los casos de transmisión por abuso sexual no han sido suficientemente documentados por lo que se desconoce su magnitud. Ante esta situación se hace necesario que las instancias correspondientes en el marco de la Ley Nº 548 "Código Niño, Niña y Adolescente", el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y otros organismos competentes unan esfuerzos para la protección y garantía de esta población, a través del desarrollo de la prevención, la investigación el diagnóstico y la atención médica y psicológica de los casos.

En este tema es necesario destacar que el Ministerio de Educación ha incorporado en el Currículo Base la Educación Integral de la Sexualidad y la prevención, atención de la violencia sexual en el Sistema Educativo Plurinacional. Este aspecto representa un logro importante debido a que se consideraba que es inadecuado para las niñas y los niños hablarles de sexualidad, aun cuando existen muchos casos de violencia sexual reportados por los medios de comunicación a diario.

3.4.2. Adolescencia

Nuestros adolescentes y jóvenes confrontan en la actualidad graves problemas sociales y de salud pública que ponen en riesgo su salud y su pleno desarrollo. La incidencia de la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) es predominante en adolescentes y jóvenes.

Para reducir este nivel de incidencia se requiere de un proceso permanente de prevención del VIH que brinde información, apoyo y servicios a los/as adolescentes y los/las jóvenes.

¿Cuáles son los riesgos de ITS/VIH/SIDA de esta población?

La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. De acuerdo con la OMS, Organización Mundial de la Salud, comprende el grupo poblacional de 10 a 19 años. Es un período de rápido desarrollo en el que se adquieren nuevas capacidades, se enfrentan situaciones nuevas y se expresan habilidades y potencialidades particulares en el proceso de adaptación. **Este grupo se caracteriza por su búsqueda de su identidad e independencia, por su alta vulnerabilidad desde el punto de vista biológico, psicológico, social y cultural.**

Imagen 2: Símbolo médico del SIDA



Fuente: https://www.freepik.es/vector-premium/cinta-roja-vector-simbolo-medico-sida-vih_20304916.htm

Un aspecto muy importante en esta etapa son los cambios hormonales con los que aparece el deseo y la atracción sexual con el consecuente inicio temprano de la actividad sexual

que en muchos casos ocurre sin la información y orientación adecuada por parte de los padres, madres, las maestras y los maestros.

Los riesgos de ITS/VIH/SIDA en la población de adolescentes y jóvenes están relacionados con el desconocimiento de las prácticas de protección y el uso consistente del condón. Con frecuencia se inician en edades tempranas, son objeto de la presión de grupo, donde puede existir también el riesgo del consumo de alcohol y otras drogas que limita la percepción de riesgo y disminuye las posibilidades de una protección efectiva.

El inicio precoz de la actividad sexual, y las desigualdades entre sexos ponen de relieve el hecho de que la educación sobre las ITS/VIH/SIDA debe ir acompañada del acceso a la educación basada en habilidades para la vida, acceso a servicios de atención integral y diferenciada para los y las adolescentes, medidas de prevención para que las mujeres jóvenes, puedan protegerse contra la violencia y la explotación sexual y la defensa de los derechos humanos.

Los y las jóvenes que no están insertos en el sistema de educación formal, los y las trabajadores, pueden no estar lo suficientemente informados para asumir comportamientos sexuales con protección por lo cual están expuestos a riesgos de adquirir el VIH/SIDA y otras ITS.

Los y las adolescentes y jóvenes con discapacidades intelectuales, visuales o auditivas pueden estar en desventaja, por lo general no se cuenta con los materiales didácticos apropiados y no se ha preparado adecuadamente a las maestras y los maestros. Estos/ Estas pueden resultar muy frágiles en términos de prevención, pueden ser objeto de explotación sexual, y por lo tanto vulnerables a las ITS/VIH/SIDA.

La Educación Integral en Sexualidad es un medio eficaz para la prevención de las ITS/VIH/SIDA en la población escolarizada, debe comprender la enseñanza de contenidos relativas a prácticas de comportamiento sexual y prevención de las ITS/VIH/SIDA apropiada a su edad acompañado de la enseñanza de habilidades para la vida lo que contribuye a que reconozcan sus riesgos y actuar con firmeza y responsabilidad ante insinuaciones sexuales no deseadas o presiones negativas de sus pares.

¿Cómo pueden prevenir las y los adolescentes las ITS/VIH/SIDA?

- Obteniendo educación sobre las ITS/VIH/SIDA y la sexualidad.
- Postergando las relaciones sexuales hasta que estén preparados/ preparadas biológica y emocionalmente y evitar consecuencias que pueden interferir con el proyecto de vida.
- Si ya se han iniciado en las relaciones sexuales deben cuidarse y protegerse usando preservativo o condón en cada relación sexual.
- Disminuyendo el número de parejas sexuales y protegiéndote en los encuentros sexuales.

- Si presentan síntomas de ITS/VIH/SIDA o su pareja, deben abstenerse de tener relaciones sexuales hasta acudir al médico/médica.
- Ambos miembros de la pareja deben recibir tratamiento médico adecuado si alguno de los dos presenta una ITS/VIH/SIDA.
- Evitando el consumo de alcohol y otras drogas porque disminuye la percepción de riesgos y hace menos probable la utilización del condón y la protección adecuada.

Promoviendo las pruebas voluntarias del VIH/Sida como medida de prevención

- Es importante que los y las adolescentes obtengan información que les permita mejorar su conocimiento sobre las ITS/VIH/SIDA y la percepción sobre la prueba de ITS/VIH/SIDA como mecanismo de prevención, lo que contribuye a la detección temprana, y a la atención oportuna de las personas que resulten infectadas por ITS/VIH/SIDA, para ello se deben priorizar las siguientes acciones:

- Diseñar e implementar talleres de formación de líderes juveniles en Salud Sexual y Salud Reproductiva, VIH y otras ITS.
- Promocionar el despistaje de ITS/VIH/SIDA en adolescentes tomando en cuenta lugares de concentración de jóvenes (refugios, centros deportivos, eventos), medios de comunicación masiva y redes sociales.
- Difundir información con el fin de sensibilizar al personal de salud en la normativa de atención integral y diferenciada para los y las adolescentes.
- Involucrar y sensibilizar a comunidades educativas, padres, madres para la prevención de las ITS/VIH/SIDA en adolescentes.
- Capacitar al personal de salud en trato digno y diferenciado, orientación pre y post a adolescentes y jóvenes garantizando la confidencialidad.

Para lograr un proceso de prevención permanente que ayude a los y las adolescentes y jóvenes a llevar una vida libre de ITS/VIH/SIDA se recomienda redoblar la atención en relación a los siguientes aspectos.

- Brindar a las y los jóvenes información y un programa completo de Educación Integral en Sexualidad.
- Lograr la participación de las y los adolescentes y jóvenes en las acciones de prevención.
- Lograr que las comunidades participen en la conformación de un entorno social positivo que promueva un comportamiento saludable en las y los adolescentes, permitiéndoles estar informados/informadas y mediante el uso de las redes sociales y los medios de difusión.
- Aumentar el número de adolescentes y jóvenes que conocen su condición serológica.

- Capacitación del personal de Salud para ofrecer servicios de salud adecuados para la población adolescente, en los aspectos relativos a la salud sexual y salud reproductiva, la prevención de las ITS/VIH/SIDA, del embarazo en adolescentes, DDHH.

ACTIVIDAD PARA EL AULA

"Tomando decisiones"

Objetivo: Analizar las consecuencias de las decisiones tomadas con relación a las relaciones sexuales coitales.

Nivel: Secundaria.

Tiempo aproximado: 45 minutos.

Desarrollo:

Nos organizamos en grupos de 3 participantes y desarrollamos las siguientes consignas:

1. Distribuir las fichas de trabajo ESCENAS.

ESCENA 1	
Una pareja ha estado saliendo durante 2 meses sin haber tenido relaciones sexuales coitales. Tras hablarlo, han decidido que van a tener relaciones coitales.	
Papel A Cree que B está "sano/sana", "limpio/limpia", no parece "raro/rara" y espera no tener que usar preservativo.	**Papel B** Sabe que cualquiera puede tener una ITS y que por tanto, deberían practicar solo sexo seguro.
OBSERVADORES Escriben los argumentos que se usa para no tener relaciones sexuales seguras, las respuestas que se dan a estos argumentos y las variaciones que se observan en función del sexo de los personajes.	

ESCENA 2	
A y B llevan un tiempo flirteando, está en un banco de un parque y han decidido ir juntos a casa.	
Papel A Quiere ir con B, pero no se quiere levantar del banco hasta dejar claro que van a tener relaciones sexuales seguras. Hablar en primer lugar.	**Papel B** No tiene ni idea de lo que es eso del sexo seguro. No le gusta nada la idea cuando A le cuenta de lo que se trata.
OBSERVADORES Escriben los argumentos que se usa para no tener relaciones sexuales seguras, las respuestas que se dan a estos argumentos y las variaciones que se observan en función del sexo de los personajes.	

2. Cada grupo decide quién será la persona A, la persona B y la observadora. Quienes observan permanecerán en silencio mientras la pareja realiza el juego de roles, escribiendo los argumentos que se utilizan para no tener relaciones sexuales seguras, las respuestas que se dan y cómo veía todo ello en función del sexo de los personajes.
3. Tras unos 8 a 10 minutos, para el juego e inicia el debate entre todos los grupos. Recoger todos los argumentos que la gente utiliza cuando no quiere relaciones sexuales seguras y en plenaria se busca respuestas a esos argumentos. Preguntas para el debate: ¿Por qué es difícil plantear tener relaciones sexuales seguras (sexo seguro) con la pareja? ¿Qué puede pensar la pareja?

- ¿Qué ocurre cuando es la mujer la que toma la iniciativa?
- ¿Es distinto cuando la iniciativa es del varón?
- ¿Cómo se siente uno/a cuando alguien te presiona para tener relaciones sexuales sin protección?
- Cómo se siente uno/a cuando alguien resiste a tu petición de tener relaciones sexuales seguras?
- ¿Cuáles son las razones que plantean los varones para no tener relaciones sexuales seguras, para no usar condones? ¿y las mujeres?
- ¿Ha logrado lo que se proponía el miembro de la pareja que estaba a favor de las relaciones sexuales seguras? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?

ACTIVIDAD PARA LA MAESTRA O EL MAESTRO

Tomando en cuenta los contenidos desarrollados en el presente cuaderno de formación, elaborar un diagnóstico que permita identificar en su comunidad educativa, factores de riesgo y factores que favorecen la prevención de ITS y VIH/SIDA.

Recopilación de la información:

- Piense qué tipo de información sobre las ITS/VIH/SIDA resultaría útil y ¿por qué?
- Recopile la información disponible sobre las ITS y el VIH para su país, departamento o municipio.
- Acérquese a su servicio de salud local para conseguir cualquier dato disponible sobre las personas que buscan tratamiento para las ITS, y averigüe si se ha realizado algún tipo de encuesta que esté basada en las pruebas de laboratorio.
- Recopile cualquier estimación sobre las ITS o el VIH además de las estadísticas o, quizás, en ausencia de éstas los efectos sociales que pueden generar.

Interpretación de la información:

- Según la información que ha recolectado, ¿quiénes se encuentran en un mayor riesgo de padecer ITS? ¿Hay grupos que estén en un mayor riesgo que otros?
- ¿En qué medida resulta útil esta información?
- ¿En qué medida las estadísticas ignoran a las mujeres? ¿Por qué?

Elaboración de las conclusiones:

- Realice gráficos simples o tablas que muestren la información que ha recopilado.
- Haga una lista de conclusiones que se podrían elaborar a partir de la información que ha recopilado.

Luego de tener los resultados del diagnóstico sobre factores de riesgo y factores que favorecen la prevención de ITS Y VIH/SIDA, elaborar un Plan de Desarrollo Curricular (PDC) que incluya el abordaje de acciones para promover la prevención desde nuestra práctica educativa.

Nota. - Mayores recursos didácticos para primaria y secundaria se pueden encontrar en los siguientes QRs.

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA

Mira el PDF: "***Guía de formación integral para estudiantes Educación Integral en Sexualidad***" de: Coordinadora de la Mujer.

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA

Mira el PDF: "***Guía de educación integral sexual para secundaria, para la prevención de la violencia de género***" de: CIES.

BIBLIOGRAFÍA

Bolivia. (2014). Ley 548 - Código Niño, Niña y Adolescente (Actualizado en 2014). Bolivia: Gaceta Nacional de Bolivia.

Casanova, G. (2004). Infecciones de Transmisión Sexual. México: Alfil.

González, R. (2008). Síndromes clínicos relacionados con violencia y victimización. México: Aragón.

Hernandez Poveda, R. (2002). Aprendamos a elaborar exámenes escritos. Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia.

Instituto Nacional de Estadística. (2017). Encuesta de Demografía y Salud Bolivia: Indicadores Priorizados. Bolivia: INE.

Martin Cisneros , L., & Ramírez Aúz, M. (2014). La Evaluación De Las Destrezas Orales. Reino Unido: Centro Virtual Cervantes.

Medrano Llano, J. L. (2014). Bolivia: Informe Nacional de Progresos en la Respuesta al VIH-SIDA. Bolivia: Ministerio de Salud.

Ministerio de Educación. (2014). Unidad de Formación Nº 4 "Medios de enseñanza en el Aprendizaje comunitario" Planificación Curricular. La Paz, Bolivia: Equipo PROFOCOM.

Ministerio de Educación - PROFOCOM. (2015). Cuaderno de Concreción Unidad de Formación N°11: Educación Inicial. La Paz, Bolivia: Ministerio de Educación.

Ministerio de Educación. (2013). Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular - Resolución Ministerial N° 143/2013. La Paz, Bolivia: Ministerio de Educación.

Ministerio de Educación. (2014). Educación Inicial en Familia Comunitaria: Lineamientos y Orientaciones Metodológicas y Programas de Estudio. La Paz, Bolivia: Ministerio de Educación.

Ministerio de Educación. (2014). Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular. La Paz, Bolivia: Ministerio de Educación.

Ministerio de Educación. (2014). Unidad de Formación Nº 3 "Estrategia de Desarrollo Curricular" Comprendiendo la Estructura Curricular. La Paz, Bolivia: Ministerio de Educación.

Ministerio de Educación. (2014). Unidad de Formación Nro 7 "Evaluación Participativa en los procesos Educativos". La Paz, Bolivia: Equipo PROFOCOM.

Ministerio de Salud. (2009). Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDSA 2008. La Paz, Bolivia: Ministerio de Salud.

Ministerio de Salud. (2015). “Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual”, Resolución Ministerial: Nº 1508. La Paz, Bolivia: Ministerio de Salud.

Ministerio de Salud. (2016). Estudio Nacional de Mortalidad Materna 2011. La Paz, Bolivia: Ministerio de Salud.

Ministerio de Salud. (06 de 08 de 2017). SNIS VE Reportes Dinámicos 2016 y 2017. Recuperado el 11 de octubre del 2018 de http://estadisticas.minsalud.gob.bo/Reportes_Dinamicos

Ministerio de Salud y Deportes. (2009). Encuesta Nacional de Demografía y Salud. La Paz, Bolivia: Ministerio de Salud y Deportes.

OMS. (2008). “Módulos de capacitación para el manejo sindrómico de la Infecciones de Transmisión Sexual”. Suiza: Ediciones de la OMS.

OPS. (2013). Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Consecuencias para la salud. Washington: Organización Panamericana de la Salud.

Organización Panamericana de la Salud. (2010). Salud sexual, reproductiva y VIH de los jóvenes y adolescentes indígenas en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú. Washington: OPS.

Pastor, Carmen. (2008). Sobre el diseño de pruebas orales. Instituto Cervantes Múnich. Recuperado el 08 de noviembre del 2019 de https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/ munich_2006-2007/08_pastor.pdf.

Quispe Mamani, E. G. (2015). Sistematización de Experiencias Socioeducativas Trasformadoras. Cochabamba, Bolivia: Artes Gráficas FOX.

Rodríguez, Ernesto. (2012). Salud Pública, Políticas Sociales y Desarrollo Humano de Adolescentes y Jóvenes Indígenas en América Latina: Experiencias Acumuladas y Desafíos a Encarar. Recuperado el 09 de octubre de http://www.celaju.net/wp-content/publicaciones/2012/11/JovenesIndigenas.pdf.

Salinas Mulder, S., & Rimassa, M. (2010). Relevamiento de Información sobre Salud General y SSR de Adolescentes y Jóvenes Indígenas en Bolivia – “Surcando caminos, develando realidades, esbozando desafíos”. Bolivia: OPS/OMS-AECID.

Solum Donas, Burak;. (2001). Adolescencia y Juventud en América Latina. Cártago, Costa Rica: Libro Universitario Regional.

T., C. (2007). Manual de capacitación en ITS para promotoras de salud. México: MEXFAM.

UNFPA. (2009). Encuesta Nacional de la Adolescencia y Juventud 2008 - Informe de Resultados. La Paz-Bolivia: Fondo de Población de las Naciones Unidas.

UNFPA. (2016). Estudio sobre el embarazo en la adolescencia en 14 municipios de Bolivia. La Paz-Bolivia, Bolivia: UNFPA.

WHO Department of Gender, Women and Health, Global Coalition on Women and AIDS. (2014). Intimate partner violence and HIV/AIDS: information sheet. Violence against women and HIV/AIDS - critical intersections. Suiza: Organización Mundial de la Salud.

GLOSARIO

- **Agente antimicrobiano:** Un agente que mata microorganismos o suprime su crecimiento o reproducción.
- **Antibiótico:** Sustancia producida por un microorganismo y que inhibe o mata a otro.
- **Cérvix:** La parte más baja del útero que se proyecta en la vagina, frecuentemente llamado cuello uterino.
- **Complicación:** Una enfermedad o trastorno secundario que puede originarse si no se trata la enfermedad primaria.
- **Conjuntivitis:** Inflamación de la membrana mucosa de los ojos y de los párpados.
- **Diagrama de flujo:** Una tabla que muestra los pasos que se deben seguir para realizar una tarea.
- **Embarazo ectópico:** Un cuadro clínico potencialmente mortal causado por un embarazo que se produce fuera del útero (generalmente en las trompas de Falopio).
- **Epidemia:** El brote de una enfermedad que afecta a gran parte de la población al mismo tiempo.
- **Evolución natural de una infección:** El curso de una infección si no recibe tratamiento (la evolución natural de las distintas ITS varía. Por ejemplo, el chancroide finalmente se cura solo, mientras que la sífilis sin tratamiento se podría extender hacia otros órganos y llevar a complicaciones, aun después de muchos años).
- **Manejo sindrómico de casos:** El manejo de una o un paciente que utiliza un síndrome (grupo consistente de síntomas y signos fácilmente reconocidos) como base para el tratamiento de los organismos causales.
- **Oftalmía neonatal:** Conjuntivitis que ocurre en un lactante menor de un mes, generalmente a causa de la gonorrea o la infección por clamidia.
- **Prenatal:** Período comprendido entre la concepción y el parto.